UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Hématologie
Interprétation d'un myélogramme
sans patient
sans geste clinique

Nom du rédacteur : Jauvert Léo

Date de rédaction : 29/11/2023

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 221 - Interprétation d'un myélogramme

Domaine de compétence n°1: Stratégie diagnostique

Domaine de compétence n°2: Synthèse des résultats d'examens paracliniques

Attendus d'apprentissage de la situation abordée:

1- Interpréter le résultat du myélogramme en prenant en compte la richesse médullaire, la présence de cellules anormales ou d'anomalies morphologiques cellulaires

2- Poser un diagnostic d'hémopathie maligne prototypique

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- 1 table, 1 chaise, 1 tableau imprimé (page 3)

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne de médecine générale en stage en hématologie clinique.

Vous êtes contacté par votre confrère du service de gériatrie à propos de M.Alain, 80 ans, hospitalisé depuis 1 semaine. Un myélogramme a été réalisé en raison de signes évocateur d'hémopathie, mais l'interne n'arrive pas à l'Interpréter et vous demande de l'aide.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Interpréter les résultats du myélogramme et donner le diagnostic le plus probable
2. Citer les 2 diagnostics syndromiques les plus susceptibles d'être présents chez le patient, en précisant leurs signes cliniques
3. Citer les anomalies possibles sur l'hémogramme et leur conséquence clinique

Richesse	Augmentée avec cellules pathologiques
Mégacaryocytes	0 sur lame
Monocytes	2% (2-3%)
Lymphocytes	8% (5-15%)
Plasmocytes	1% (1-3%)
Myéloblastes	31% (2-3%)
Promyélocytes	62% (4-8%)
Myélocytes	4% (10-15%)
Métamyélocytes	2% (15-20%)
Polynucléaires neutrophiles	7% (20-30%)
Polynucléaires éosinophiles	0% (1-4%)
Polynucléaires basophiles	0% (0,5-1%)
Pro-érythroblastes	0% (1-2%)
Erythroblastes basophiles	1% (4-8%)
Erythroblastes polychromatophiles	2%(6-10%)
Erythroblastes acidophiles	3% (4-10%)
Myélopéroxydase naphtol	Positive avec présence de corps d'Auer en fagots

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Relève l'augmentation de la richesse de la moelle	
Décrit l'absence d'anomalie de la lignée lymphoïde	
Conclut à une anomalie touchant la lignée myéloïde de manière isolée	
Relève la présence d'une augmentation **>20% des blastes**	
Relève l'augmentation des promyélocytes (*orientant vers la LAM 3)*	
Relève les corps d'Auer (*orientant vers la LAM)*	
Parle de hiatus de maturation ET/OU de blocage de maturation	
Énonce le diagnostic de leucémie myéloblastique aigue à promyélocytes OU LAM 3	
Tache 2	
Évoque la présence d'un syndrome tumoral *(hépatomégalie, adénopathies, splénomégalie, hypertrophie gingivale : FAIT si 2 signes cités)*	
Évoque la possible présence d'un syndrome de leucostase (*Ralentissement psychomoteur, céphalées, troubles de la vigilance, dyspnée) : FAIT si 1/3 cités)*	
Tache 3	
Évoque une anémie (*paleur, dyspnée, asthénie, vertige, palpitation OK sur 2/5*)	
Évoque une thrombopénie (*saignements cutanéomuqueux OU purpura* OK si 1/2)	
Évoque la forte probabilité de CIVD (*thrombose vasculaire et saignement*) L'étudiant doit dire les 2	
Évoque la leucopénie (*syndrome infectieux ; angine ulcéro-nécrotique OK si ½)*	
COMPETENCES GENERIQUES	
Organise sa synthèse des examens paracliniques	1 à 5
Justifie son raisonnement diagnostique	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Cocher si fait
Tache 1	
Relève l'augmentation de la richesse de la moelle	1
Décrit l'absence d'anomalie de la lignée lymphoïde	2
Conclut à une anomalie touchant la lignée myéloïde de manière isolée	2
Relève la présence d'une augmentation **>20% des blastes**	2
Relève l'augmentation des promyélocytes (*orientant vers la LAM 3)*	2
Relève les corps d'Auer (*orientant vers la LAM)*	2
Parle de hiatus de maturation ET/OU de blocage de maturation	1
Énonce le diagnostic de leucémie myéloblastique aigue à promyélocytes OU LAM 3	2
Tache 2	
Évoque la présence d'un syndrome tumoral *(hépatomégalie, adénopathies, splénomégalie, hypertrophie gingivale : FAIT si 2 signes cités)*	3
Évoque la possible présence d'un syndrome de leucostase (*Ralentissement psychomoteur, céphalées, troubles de la vigilance, dyspnée) : FAIT si 1/3 cités)*	3
Tache 3	
Évoque une anémie (*paleur, dyspnée, asthénie, vertige, palpitation OK sur 2/5*)	2
Évoque une thrombopénie (*saignements cutanéomuqueux OU purpura* OK si 1/2)	2
Évoque la forte probabilité de CIVD (*thrombose vasculaire et saignement*) L'étudiant doit dire les 2	2
Évoque la leucopénie (*syndrome infectieux ; angine ulcéro-nécrotique OK si ½)*	2
COMPETENCES GENERIQUES	
Organise sa synthèse des examens paracliniques	1 à 5
	Total / 40